PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Concussão relacionada ao esporte

Reconhecer, retirar e conduzir o retorno

Medicina Esportiva Clínica

A lesão em que a decisão errada custa mais do que a lesão

A tomografia

costuma vir normal

exclui sangramento, não concussão: nenhum exame decide por você

A decisão é clínica, rápida, sob pressão

e é tomada três vezes

à beira do campo — **em casa** — **no vestiário**

AS TRÊS DECISÕES DA AULA

Trinta segundos, quarenta e oito horas, sétimo dia

30 segundos — **48 horas** — **7º dia**

À beira do campo

o meia cambaleia e diz que está bem: dá para continuar?

Na casa da família

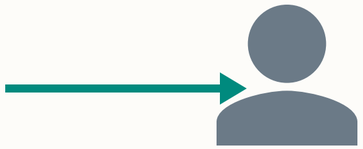
o adolescente no domingo: escola, celular, quarto escuro?

No vestiário

“estou zerado, posso treinar com contato?”

> O diagnóstico é médico. Reconhecer e retirar de campo não é, e é aí que o sistema mais falha.

Três equívocos que ela resolve

~~“Não bateu a cabeça.”~~	~~“Não desmaiou.”~~	~~“A tomografia deu normal.”~~
	**< 10% perdem a consciência**	
a força chega pelo ombro, pelo tronco, pela queda	perda de consciência em menos de 10% dos casos	é o esperado; ela exclui sangramento, não concussão

> Os sintomas podem aparecer em minutos ou horas. Quem estava bem no intervalo e piora à noite continua suspeito.

Consenso de Amsterdã, Br J Sports Med 2023

DECISÃO À BEIRA DO CAMPO

Um único sinal basta

Demora para levantar

sem causa aparente

Incoordenação

cambaleio, passos instáveis

Olhar vago

parado, desconectado

Postura tônica ou abalos

retirada imediata e avaliação urgente

Confusão

não sabe o placar, repete perguntas

O que ele relata

dor de cabeça, náusea, tontura, lentidão

um sinal basta

sai de campo para ser avaliado

Não volta no mesmo dia, em nenhuma idade

Reconhecer: qualquer pessoa

- cartão CRT6
- feito para quem não é da saúde
- não diagnostica
- decide quem sai para ser avaliado

retira: não volta no mesmo dia

Avaliar: o médico

SCAT6	13 anos ou mais
Child SCAT6	8 a 12 anos
até 72 h	maior sensibilidade
após 1 semana	versão de consultório

> Retirar não é diagnosticar. É tirar do risco quem pode estar lesionado.

SCAT6 e CRT6, Br J Sports Med 2023

QUANDO A SUSPEITA VIRA EMERGÊNCIA

Não mover, 192, hospital

Consciência

perda prolongada ou nível piorando; comportamento muito alterado

Cabeça

vômitos repetidos, dor que piora, pupilas diferentes, convulsão

Neurológico e coluna

fraqueza, formigamento, fala arrastada, suspeita de lesão cervical

- não mover
- 192
- hospital

POR QUE A REGRA É QUEBRADA

E o que ajuda a cumpri-la

O atleta subnotifica

vaga, contrato, final; o órgão lesionado é o que se autoavalia; “disse que está bem” não é dado clínico

O técnico decide sob pressão

não é maldade, é a função; a retirada não deveria depender dele



A regra tira o peso do banco

substituição adicional por concussão

aprovada pela IFAB em 2024; adotada pela CBF, a primeira confederação da FIFA a implantá-la

não conta nas trocas normais

IFAB 2024 · CBF, relatório dos campeonatos brasileiros de 2024

DECISÃO NA CASA DA FAMÍLIA

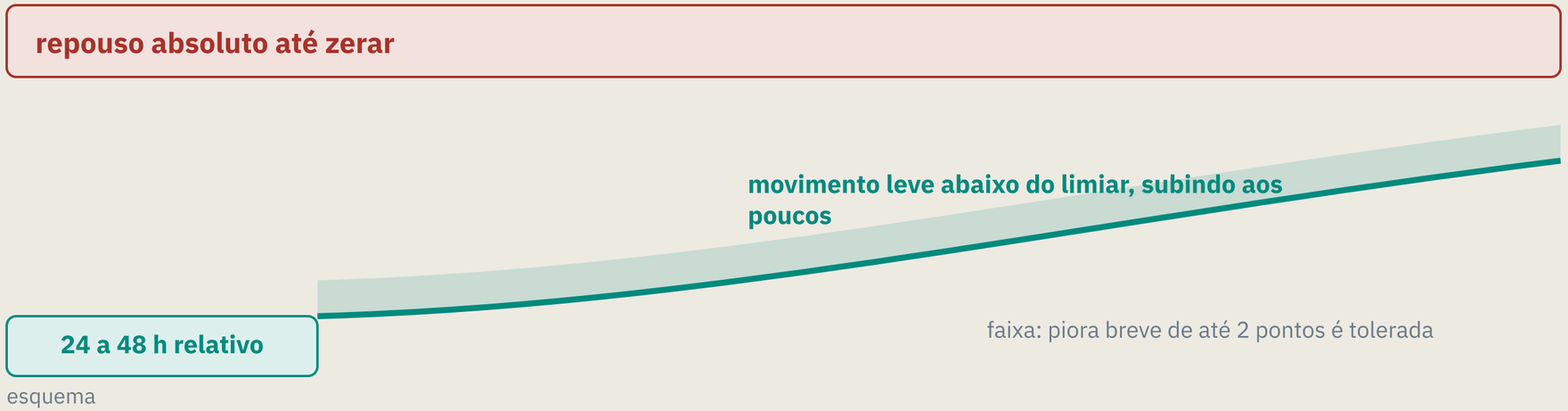
A recomendação mudou

A orientação antiga

quarto escuro, sem tela, sem escola, por dias

A orientação atual

tela limitada, sono priorizado; álcool não



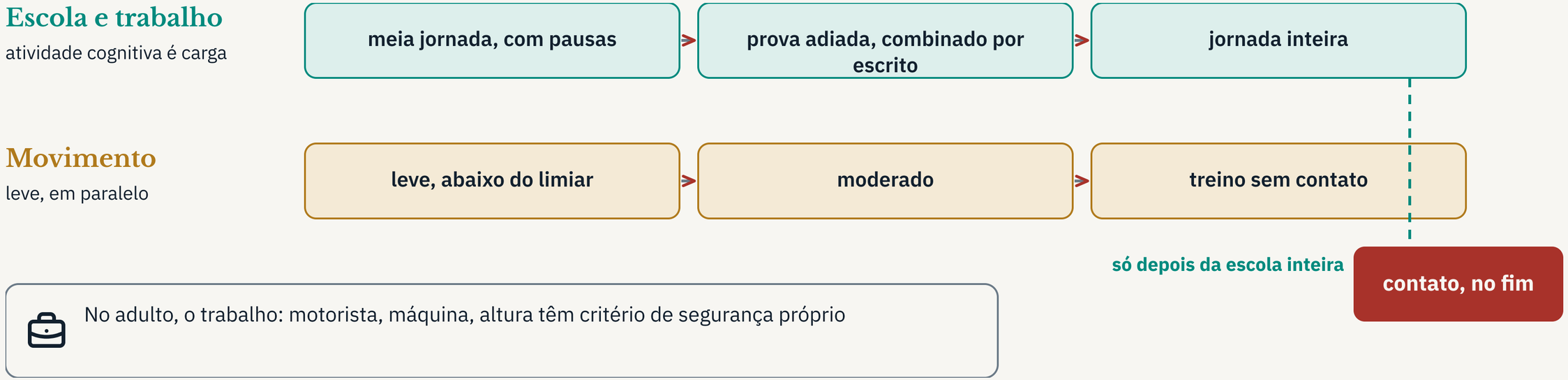
esquema

> Álcool não. Analgésico só com orientação. Sinais de alarme entregues por escrito.

Consenso de Amsterdã 2023

A ORDEM QUE QUASE TODO MUNDO INVERTE

Escola e trabalho antes do contato



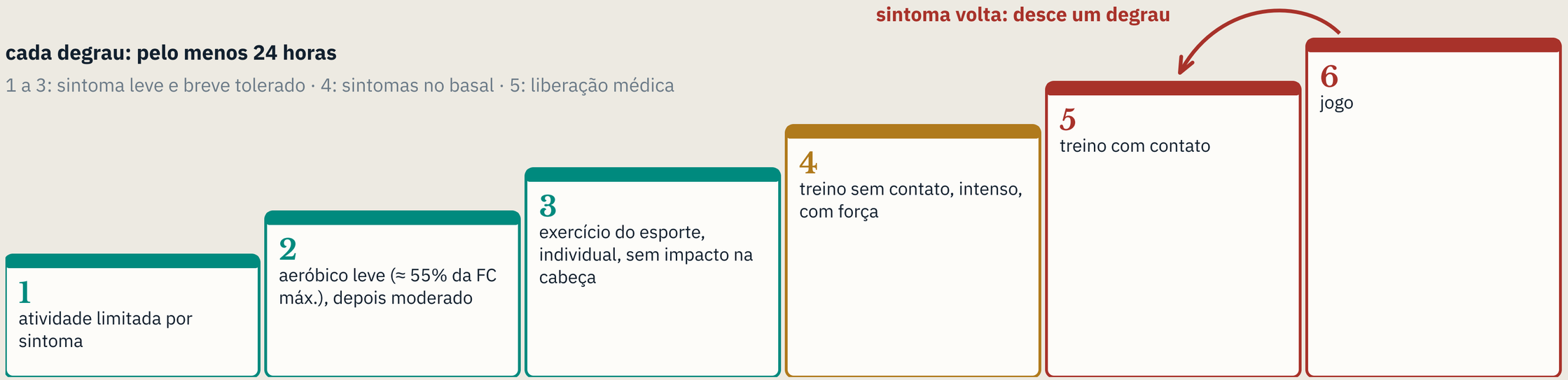
No adulto, o trabalho: motorista, máquina, altura têm critério de segurança próprio

DECISÃO NO VESTIÁRIO

Seis degraus, pelo menos 24 horas cada

cada degrau: pelo menos 24 horas

1 a 3: sintoma leve e breve tolerado · 4: sintomas no basal · 5: liberação médica



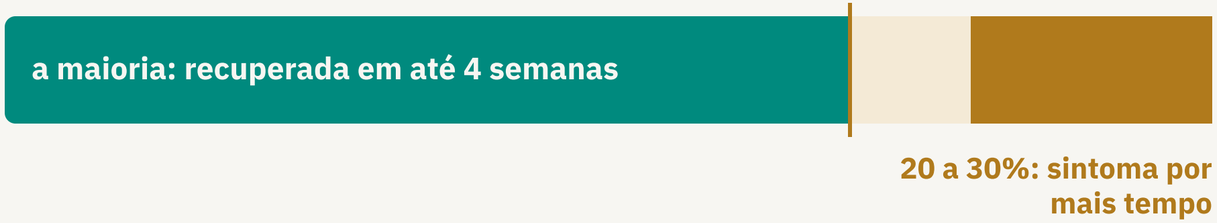
Sintoma que volta faz retroceder. Assintomático em repouso não é liberado: o teste é tolerar carga.

Estratégia de retorno ao esporte, consenso de Amsterdã 2023

QUANDO A RECUPERAÇÃO DEMORA

Não é frescura, e esperar parado é o erro

Jovens e adultos com concussão



esperar parado é o erro: quem demora tem frentes tratáveis

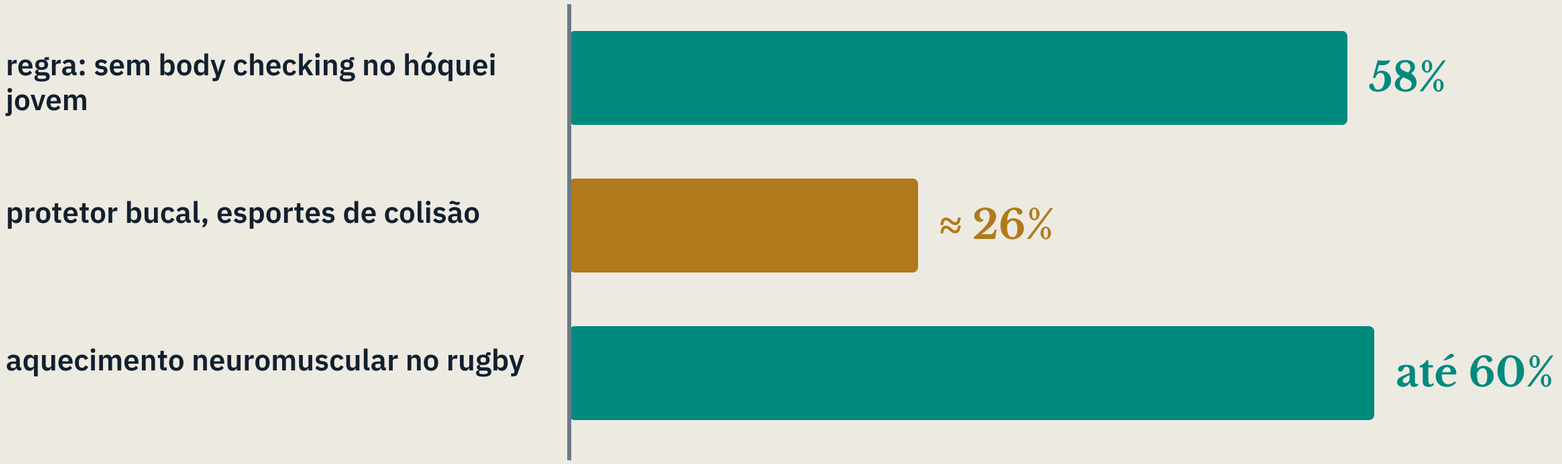
- **pescoço**
- **sistema vestibular**
- **visão**
- **humor e sono**

> Encefalopatia traumática crônica: preocupação legítima, associação descrita, causa e risco individual não estabelecidos. Reduzir exposição já se justifica hoje.

Consenso de Amsterdã 2023

PREVENÇÃO COM DADO

Regra primeiro, equipamento depois



menos concussão, em redução relativa; estudos diferentes

Sem evidência como prevenção

- ~~faixa de cabeça~~
- ~~suplemento neuroprotetor~~
- ~~imagem de rotina~~

Custo zero: ensinar a comissão e limitar contato no treino.

Revisão sistemática do consenso, Br J Sports Med 2023

AS TRÊS DECISÕES, RESPONDIDAS

Sai, repousa pouco, sobe degrau por degrau

- Um sinal basta, e não volta no mesmo dia
- Repouso relativo curto; movimento leve entra cedo; escola antes do contato
- Seis degraus, 24 horas cada, contato com assinatura médica

Qualquer pessoa da comissão

Reconhece e retira. Retirar não é diagnosticar.

Médico

Diagnostica, avalia com SCAT6, indica imagem, libera o contato.

Preparação, fisio, psicologia

Conduzem os degraus, tratam pescoço e equilíbrio, cuidam do medo de voltar.

A conversa com escola, família e clube é parte do tratamento.